Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 28ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0045748-18.2023.8.17.2001**
AUTOR: ABNER COSME DEIRO NETO
RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
SENTENÇA – extinção com resolução do mérito
Vistos etc

ABNER COSME DEIRO NETO propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS contra a **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, afirmando que é segurado do plano de saúde na condição de dependente e está com suas obrigações junto à operadora regulares.

Aduz que foi diagnosticado como portador de Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual GRAVE - CID-10: F33.2 e Transtorno de Ansiedade Generalizada - CID-10 F41.1, associado a comorbidades, tais como: hérnia de disco e arritmia.

Nesse contexto, desde novembro do ano de 2022, encontra-se em tratamento psiquiátrico regular, com a médica psiquiatra, Dra. Elizabeth Gonçalves - CRM 22826 e, apesar de já ter se submetido a vários tratamentos com o uso de medicamentos antidepressivos diversos, não obteve êxito na estabilização da sua doença, que se mostra extremamente refratária aos tratamentos médicos habituais, conforme explica a profissional que vem acompanhando o quadro clínico do Autor.

Em virtude do quadro de saúde grave do paciente, conceituado como "UMA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA QUE EXIGE INTERVENÇÃO IMEDIATA", a médica psiquiatra, Dra. Elizabeth Gonçalves, CRM 22826, prescreveu o uso da Cloridrato de Escetamina (SPRAVATO).

Continua afirmando que não se trata de medicamento oral antidepressivo "comum", porquanto, enquanto o medicamento oral pode demorar semanas até fazer os efeitos desejados e essa situação deixa uma janela indesejada entre a ingestão dos medicamentos e a melhora do quadro psicológico do paciente, aumentando ainda mais o risco de suicídio, a "Escetamina", princípio ativo do medicamento "Spravato" atua nos receptores de glutamato, molécula responsável por melhorar as conexões entre os neurônios.

Informa que o medicamento "Spravato", de acordo com a literatura médica, e já devidamente comprovado cientificamente, diminui o lapso temporal entre a ideação suicida e a execução do ato atentatório à própria vida.

Fez referência que, ao solicitar o procedimento ao plano, recebeu a negativa argumentando o plano que o contrato não tem cobertura para o medicamento solicitado, e portanto não teria obrigatoriedade de cobertura segundo a Lei 9.656/1998.

Em face disso, requereu em **tutela de urgência** que a demandada autorize, imediatamente, administração da medicação em caráter ambulatorial, sendo indicada pela médica assistente a clínica especializada: DOMU - TERAPIA AMBULATORIAL ASSISTIDA.

Juntou os documentos de ID 131432105 a 131436747.

Concedida a tutela de urgência (Decisão ID 131624032), para cobertura na rede credenciada, e em não havendo, para que seja realizada na clínica de escolha do paciente.

O réu apresentou comprovação do cumprimento da decisão (petição ID 132195440 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5290333&ca=2cfed323340c9a25b6a26fd7f56fb73f9875d3f57c0c2983b7ea174862589e9fb13902cl

Após informação de descumprimento da tutela pelo autor, fora dada nova decisão, para excluir a especificação da clínica particular na decisão concessiva de tutela (id. 132572205 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5290333&ca=2cfed323340c9a25b6a26fd7f56fb73f9875d3f57c0c2983b7ea174862589e9fb13902cl

Contestação ID 132843727 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5290333&ca=2cfed323340c9a25b6a26fd7f56fb73f9875d3f57c0c2983b7ea174862589e9fb13902cl

Réplica no ID 140676950.

Posteriormente a parte Autora peticionou requerendo continuidade do tratamento consoante laudo médico, o que foi deferido pelo Juízo (id. 133944929 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5290333&ca=2cfed323340c9a25b6a26fd7f56fb73f9875d3f57c0c2983b7ea174862589e9fb13902cl 140931169 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5290333&ca=2cfed323340c9a25b6a26fd7f56fb73f9875d3f57c0c2983b7ea174862589e9fb13902cl

Intimadas as partes para apresentação de provas, a Demandada requereu a produção de prova pericial, e a parte autora o julgamento antecipado.

Por último, a parte autora informa o descumprimento da tutela em razão da interrupção do tratamento (id. 156412796 (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=5290333&ca=2cfed323340c9a25b6a26fd7f56fb73f9875d3f57c0c2983b7ea174862589e9fb13902cl

Os autos me foram apresentados.

É o que importa relatar. Passo à decisão.

O caso é de julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, sendo despicienda a prova técnica pericial requerida pela Ré, já que a prova documental constante nos autos é suficiente para a solução da lide.

Deste modo, as versões dos fatos que constroem a causa de pedir da prestação jurisdicional e a tese da defesa já se apresentam suficientemente claras e enunciadas, a partir do teor das peças atrial, de bloqueio, de réplica e das provas documentais figurantes no bojo dos autos eletrônicos, sobretudo os diversos laudos médicos assinalados pelo médico que assiste o autor.

Entender o contrário afronta os primados da celeridade, da economia processual, da duração razoável do processo e da própria cooperação entre os sujeitos do processo.

Das preliminares.

A parte Demandada pede o chamamento ao feito do ESTADO, pois aduz que o fornecimento do medicamento objeto da ação é de obrigação do SUS.

Incabível tal pleito.

O caso discute obrigação contratual de plano de saúde e, portanto, não há que se falar em intervenção do Estado, mas sim da análise da obrigação de fazer com base no instrumento pactuado, que não pode ser delegado ao Estado.

Dito isto, rejeito a presente preliminar.

Não obstante a parte Demandada pleiteie a realização de perícia médica, tenho que, no caso em debate, a concretude de prova pericial se faz desnecessária, tendo em vista que a questão controvertida gira em torno de se verificar se a medicação prescrita pelo *expert* deve ser fornecida pelo Plano de Saúde Réu, em razão do contrato firmado entre as partes.

Ou seja, não se discute se o autor é ou não acometido da patologia descrita na inicial mas sim, se o mesmo detém o direito de que o plano de saúde custeie o tratamento com o fornecimento da medicação.

Neste norte, insta salientar que é consabido que o juiz, na condição de destinatário das provas, possui a prerrogativa de dirigir o processo, o que inclui, por vezes, decidir pela pertinência e relevância das provas cuja produção é requerida pelas partes.

Nessa perspectiva, deve o magistrado prezar por uma instrução probatória capaz de elucidar o contexto fático debatido na ação de forma satisfatória a possibilitar, além de seu convencimento próprio, o daqueles julgadores que eventualmente apreciarão a lide em outros graus de jurisdição.

Nesse diapasão, é certo que o feito no estado em que se encontra possui elementos mais do que suficientes a possibilitar que o julgador – seja ele de qualquer instância – forme seu convencimento de forma segura, restando, portanto, despicienda a realização de perícia médica, posto se tratar da aferição do preenchimento de requisitos estabelecidos em diploma legal.

Por estas razões INDEFIRO o pedido para realização de perícia.

Passo a examinar o mérito.

De início, cumpre deixar consignado, desde logo, que a relação jurídica travada entre as partes e que constitui o substrato do objeto desta ação, possui natureza consumerista, uma vez que o autor é o destinatário final dos serviços prestados pela empresa ré, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tal conclusão possui como consequência jurídica a incidência na hipótese das regras e princípios previstos na Lei nº 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé objetiva que, em relação ao consumidor, é presumida por aquele Diploma Legal, a qual não foi elidida pela ré durante o feito, como lhe competia, em virtude da inversão do ônus da prova também autorizada pela Legislação Consumerista.

Feitos tais esclarecimentos iniciais necessários, verifica-se que, quanto à matéria de mérito, as justificativas apresentadas pela empresa-ré não têm como serem aceitas.

A parte autora noticiou a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso pela justificativa da não previsão contratual e ausência de cobertura obrigatória no rol da ANS.

A recusa da demandada destoa da finalidade do contrato, relacionado com a saúde e, portanto, com a própria vida, direitos que integram os "direitos fundamentais" protegidos pela Constituição Federal.

O laudo bastante detalhado exarado pela médica que assiste o autor (Id. 131433908) é claro ao assentar a necessidade do autor de submissão ao tratamento com o medicamento SPRAVATO **"em caráter de urgência"**, diante do estágio de depressão do autor que não vem respondendo ao uso de medicações comuns, administrados desde o início do tratamento em novembro/2022.

Destaca a médica que o autor vem com ideação suicida e descreve minimamente as vantagens e benefícios de se preferir a utilização do medicamento requerido.

Merece destaque o seguinte trecho do laudo:

> "(...)Ressalto que segundo a literaturas médicas, os antidepressivos orais monoaminérgicos, podem levar semanas ou até meses para atingir o efeito ideal, e esse fator nos leva a um intervalo de tempo muito curto entre o surgimento da ideação suicida e a tentativa de suicídio, além de ele ter contra-indicação formal por ter arritmia cardíaca. Levando em consideração todos esses fatos, eu como médico psiquiatra assistente da paciente Abner Cosme Deirò Neto vejo que no cumprimento do meu trabalho, devo utilizar a terapia mais indicada para esse paciente, afim de promover o resgate do quadro grave em que se encontra, pois é sabido que a suicidalidade aguda é uma emergência psiquiátrica que exige intervenção imediata, e o intervalo de tempo entre o surgimento da ideação suicida e a tentativa de suicídio é geralmente muito curto.
> Portanto, considerando-se o diagnóstico atual do paciente (CID-10: F33.2), o risco iminente de suicídio, considerando ainda que as atuais medicações levarão pelo menos algumas semanas pra reduzirem os sintomas depressivos e o risco de autoextermínio do paciente, é solicitado a operadora de saúde Unimed Recife o tratamento abaixo:Liberação urgente da medicação SPRAVATO a ser iniciado imediatamente, na dosagem de 56mg (2 dispositivos), pela operadora de saúde Unimed Recife, dando continuidade ao tratamento conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA, por quatro semanas, realizando 2 aplicações de 56mg (2 dispositivos em cada aplicação) por semana em dias alternados na Clínica DOMU - Terapia Ambulatorial Assistida (...)"

Os elementos que constam dos autos, em especial, a defesa oferecida, realmente indicam que houve recusa por parte do réu em liberar o medicamento indicado pelo médico como sendo necessário para a continuidade do tratamento.

O réu alegou, em sua defesa, que a recusa decorre do disposto no contrato e do fato do medicamento não estar entre aqueles de caráter obrigatório, conforme regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde.

Entendo, no entanto, e respeitados os argumentos apresentados, que o medicamento indicado não apresenta caráter experimental, sobretudo por representar tratamento que foi indicado pelo profissional que acompanha o autor.

O fato de não ser obrigatório, não indica que não tenha que ser proporcionado pelo réu.

O tratamento a ser desenvolvido, exames e a técnica utilizada devem ser discutidos pelo médico e paciente sem a interferência do convênio médico, desde que respeitados os limites previstos no contrato e a utilização de medicamentos devidamente aprovados pela Anvisa e recomendados pela Agência Nacional de Saúde.

No caso dos autos, o réu não juntou documento capaz de comprovar a ausência de aprovação do medicamento pelas autoridades brasileiras. Ao contrário, confirmou a sua utilização (id.132845587) e apenas justifica a sua recusa pelo fato de não ser obrigatório.

Ocorre que a ausência de obrigatoriedade não é causa suficiente para a recusa na medida em que compete ao réu arcar com os valores destinados ao diagnóstico e tratamento, desde que devidamente liberados pela Agência Nacional de Saúde, tal como ocorre no caso.

A questão deduzida nos autos não é nova e já vem sendo tratada pela jurisprudência, conforme ementa a seguir transcrita:

> "Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho 1ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0017948-67.2023.8.17.9000 AGRAVANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADA: ROGERIO CAVALCANTI DA COSTA PINTO RELATOR: DES. RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR. SPRAVATO SPRAY (ESCETAMINA). APROVADO PELA ANVISA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE COM TENDÊNCIAS SUICIDAS. INSUCESSO DE TRATAMENTOS TRADICIONAIS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DA DEMORA INVERSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de duas Apelações Cíveis, sendo as partes acima indicadas, acordam, os Senhores Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco acordam, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator
> (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0017948-67.2023.8.17.9000, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 20/12/2023, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC))
>
> AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 00015647-50.2023.8.17.9000 AGRAVANTE: UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADA: DANIELE CLAUDINO MACIEL PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0067766-33.2023.8.17.2001 -SEÇÃO A DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL RELATOR: DES. MÁRCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. DROGA REGISTRADA PELA ANVISA E RECOMENDADA POR ÓRGÃO TÉCNICO.

NEGATIVA INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. - Autora que foi diagnosticada com "transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos" (CID 10 – F33.2), com acompanhamento desde 2019, apresentando quadro depressivo crônico grave de longa duração (pontuação de 50 pela escala de Montgomeru Asberg para depressão – MADRS, quando o máximo é de 60 pontos), associado a fibromialgia, além de manifestar pensamento suicida e estar em uso da combinação de duloxetina, brexpiprazol, bupropiona, clonazepam e pregabalina, sem atingir a remissão do quadro depressivo e com persistência de sintomatologia incapacitante, motivo pelo qual a médica assistente indicou o tratamento com a medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) - Cobertura do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) para tratamento de Transtorno Psiquiátrico grave. Droga com registro na Anvisa e com indicação em nota técnica do e-natjus do CNJ, que recomenda a utilização do medicamento em caso semelhante e após a utilização de diversos medicamentos sem efeito - Cabe ao médico assistente do paciente indicar o melhor tratamento para alcançar a cura, e não ao plano de saúde de forma unilateral - Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, após a regularização do medicamento junto a ANVISA, não mais persiste o direito da seguradora em recusar a cobertura do tratamento medicamentoso com indicação do médico responsável pelo beneficiário (AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022) - Art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998 (Lei de Planos de Saúde), incluído pela Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que prevê a cobertura de tratamento pela operadora mesmo em caso de não se encontrar listado da referência básica da ANS, quando "(I) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (II) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais" - Hipótese de urgência, diante do quadro do paciente, com necessidade de realização do tratamento em menor tempo possível, a fim de minimizar os danos a sua saúde, o que evidencia o perigo de dano - Probabilidade do direito que milita em favor da agravada, uma vez que a doença restou comprovada, o tratamento foi indicado pelo médico, com a necessidade de medicamento, e a seguradora não conseguiu demonstrar, pelo menos nesse momento, a exclusão contratual dos procedimentos correlatos - Ausência de concessão da tutela antecipada que poderá, em face da natural marcha processual, tornar, no futuro, inócua a prestação jurisdicional, pois pode acarretar na impossibilidade de a parte autora ter o tratamento adequado em virtude da omissão da cobertura ora pleiteada - Inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (art. 300, § 3º, do CPC), porquanto sua eventual revogação autorizará que a parte ré proceda à cobrança das diferenças apuradas - Agravo de instrumento não provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 00015647-50.2023.8.17.9000, da Comarca de Recife, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEXTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, voto e ementa que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. Des. Márcio Aguiar Relator

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0015647-50.2023.8.17.9000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 05/12/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

"Apelação Cível - Plano de Saúde - Sentença confirmou tutela e condenou a ré a autorizar o tratamento com uso do medicamento Cloridrato de Escetamina, 28 mg, por via intranasal - Apelo da ré - Preliminar - Alegação de julgamento fora dos pedidos da lide - Sentença que respeitou os limites do pleito inicial, determinando o reembolso integral de todos os gastos que o autor teve com a negativa de cobertura do medicamento - Pedido do autor, para condenar a ré ao custeio de todas as despesas decorrentes do tratamento com o medicamento requerido - Observância ao princípio da adstrição - Preliminar rejeitada. Mérito - Obrigações assumidas pelos que atuam no ramo da saúde, voltam-se a garantir o direito fundamental à vida - Afastamento da restrição de cobertura nos casos em que afetam a própria natureza do ajuste firmado entre as partes - Nulidade da cláusula limitativa, se há recomendação médica para o tratamento - Inteligência do art. 51, IV, §1º, II do CDC - Rol da ANS que encerra coberturas obrigatórias mínimas e não pode servir de justificativa negativa de cobertura quanto se está diante de doença coberta em tratamento recomendado pelo médico do paciente - Aplicabilidade das Súmulas 96 e 102 do TJSP - Eficácia do tratamento medicamentoso atestada por médico que acompanha o autor Negativa de custeio pela ré comprovada - Medicamento com registro na ANVISA com validade até 2030 - Manutenção de custeio integral do tratamento - Precedentes jurisprudenciais - Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil - Sentença mantida (nos moldes do Art. 252 do Regimento Interno do ETJSP) - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível nº. 1025682-62.2022.8.26.0100; Relator(a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central da Capital – 18ª Vara Cível - Data do Julgamento: 07/11/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de depressão e outras comorbidades. Prescrição de tratamento com medicamento Spravato. Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente jurisprudencial. Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde. Necessidade de resguardar o direito à vida. Cobertura determinada. Dano moral. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. Recurso da ré parcialmente provido, restando prejudicado o recurso da autora." (TJSP; Apelação Cível nº. 1019547-97.2023.8.26.0100; Relator(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central da Capital – 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2023).

Aliás, a lei 14.307/2022 c/c a lei 14.454/2022 que alterou a Lei 9.656/1998, e trata sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito de saúde suplementar dispõe:

§ 12. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm#art10%C2%A712) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela

ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou**

II - **existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR) -** grifei

Observo que consta nos autos o parecer produzido pela CREMEC (id.132845587), que comprova a efetividade do tratamento com o medicamento SPRAVATO para o tipo de moléstia que acomete o autor.

Assim, a novidade legislativa estabeleceu expressamente que o rol da ANS se trata de rol meramente exemplificativo, estabelecendo apenas dois requisitos alternativos para a sua flexibilização.

Do mesmo modo, não é cabível admitir a argumentação de que o medicamento não seria indicado para o autor, em razão de ser acometido de problemas cardíacos.

Cabe ao médico a prescrição aos seus pacientes de exames, tratamentos, procedimentos e medicamentos essenciais para o restabelecimento de sua saúde, levando em consideração a evolução da técnica e ciência médica.

Em consequência, devem as operadoras do plano ou seguro saúde acompanhar tal evolução independentemente de alteração administrativa do rol de procedimentos obrigatórios apontados como cobertura mínima pela Agência nacional de Saúde ANS.

É evidente que estamos diante de uma excepcionalidade, levando o alto grau de risco do paciente tirar a própria vida.

A ré, ao negar o fornecimento do tratamento, ofende o padrão de confiança e lealdade que deve orientar as relações jurídicas, age com comportamento ilícito, abusando de seu poder e frustrando as legítimas e justas expectativas da autora.

De fato, tolerar a conduta de feição negativa da ré equivale a ignorar a essencialidade do objeto do contrato e o conteúdo social deste, idealizado para a tutela adequada da pessoa humana, tornando sua existência mais digna.

Compactuar com a recusa manifestada pela ré corresponde a atenuar o compromisso e a responsabilidade por ela, contratual e legalmente, assumidos, deixando a parte autora de mãos atadas, em situação de exagerada desvantagem, incompatível com o princípio da boa-fé e o equilíbrio do ajuste, porquanto importa restrição a direitos fundamentais próprios da natureza e da finalidade do contrato (direito à vida e à saúde), o que é vedado por lei (artigo 51, I, IV e § 1º, I e II, do CDC).

Em se tratando de exclusão de cobertura, ela não pode ser estatuída de modo residual, ou seja, sob o raciocínio de que o que não está previsto está excluído. Do contrário, arrogar-se-ia a operadora na prerrogativa de controlar casuisticamente extensão de sua obrigação, autorizando ou negando cobertura de forma arbitrária e abusiva.

Portanto é de rigor a obrigatoriedade do plano do autor custear e realizar o procedimento/medicamento requerido.

Por seu turno, no que diz respeito à **indenização por danos morais,** vê-se que a relação que une as partes está submetida às regras de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e, em se tratando de contrato de adesão, sua interpretação deve ser direcionada a compreendê-lo da forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), sobretudo diante da realidade narrada nos presentes autos, vez que, os princípios e preceitos insculpidos no mencionado Diploma, derrogam as disposições contratuais que com eles colidirem.

O dano moral consiste na lesão a um interesse ou bem juridicamente protegido e seu ressarcimento visa a uma satisfação extrapatrimonial do indivíduo. Justamente por não serem passíveis de aferição econômica, a prestação pecuniária, em caso de lesão a algum destes bens, tem função meramente satisfatória, procurando compensar, até certo ponto, o dano injusto pelas vantagens e satisfação que o dinheiro poderá proporcionar.

Assim, considerando que o dano moral, neste caso, embora não tenha como foco a honra ou imagem da vítima, decorre do mal físico que lhe foi causado, torna-se prudente convir que a situação do autor diante da negativa da ré não se configurou compatível com a necessidade de seu tratamento.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Como sabido, o arbitramento do dano moral é fixado pelo julgador, utilizando-se, para tanto, do critério da fixação equitativa, tendo em vista a repercussão do dano, a intensidade do dolo ou culpa, bem como a possibilidade econômica das partes.

A indenização deverá ser proporcional ao dano sofrido (art. 944 do Código Civil), com as seguintes finalidades: a) compensatória à vítima pela lesão à honra e à integridade moral, não se permitindo que o dano seja fonte de lucro; b) pedagógica, com o fito de evitar que condutas abusivas sejam novamente praticadas em detrimento de outros consumidores.

Por conseguinte, em casos como tais, deve o julgador utilizar o critério da razoabilidade, aferindo as causas e consequências do ato ilícito.

Face ao exposto, e atento a tudo o mais que dos autos consta, com base no art. 487, I do Código de Ritos, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito para:

- CONFIRMAR, e tornar definitiva, a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que a parte Requerida, NO PRAZO DE CINCO DIAS. custeie/forneça ao requerente a medicação como prescrita pelos médicos que o assistem (Dra. Elizabeth Gonçalves – CRM 22826-PE e Dr. Luiz Evandro de Lima Filho – CRM 18394PE) sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (alcançando o valor máximo de R$ 100.000,00 – cem mil reais), a ser revertida em favor do demandante, ***caso ainda não o tenha feito*** *(o tratamento com a medicação SPRAVATO em caráter AMBULATORIAL, preferencialmente em sua rede credenciada, na quantidade de sessões indicadas pelo médico assistente que por último assinalou a necessidade de prorrogação do tratamento por mais 6 meses)*;

- CONDENAR a Demandada UNIMED RECIFE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, consoante textualizado nos fundamentos desta decisão, a pagar ao demandante, à título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido com base na tabela do

ENCOGE, tendo-se por termo a quo a data da presente decisão (Enunciados das Súmulas n. 362 e 160 do STJ e do TJPE, respectivamente); cominando-se, ainda, juros de mora no percentual de 1% (art. 406 do CC em vigor e a sua combinação com o art. 161, § 3º, do CTN), tendo-se por termo inicial a data da citação;

A obrigação do réu deverá ser cumprida mediante a apresentação, *periódica*, de prescrição médica atualizada, comprovando a necessidade de continuação do uso da medicação, a fim de que seja impedido qualquer desvio de finalidade no fornecimento do fármaco em questão, protegendo a finalidade pública da presente decisão.

Registre-se que a intimação da parte requerida para que CUMPRA A PRESENT DECISÃO deve se dar PESSOALMENTE, através de carta com aviso de recebimento;

- CONDENAR a demandada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo que estes, por força do art. 85, §2º, I a IV, do novel Código de Processo Civil, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Contador do Juízo a fim de que seja verificada a existência de custas processuais pendentes. Em havendo, intime-se a parte Devedora para o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 20% sobre o valor do débito, nos termos do Art.22, da Lei 17.116/2020.

No caso de inércia, remetam-se ao Comitê Gestor de Arrecadação/Procuradoria Geral do Estado, conforme seja o caso, a documentação listada no Art. 27, §3º, da Lei 17.116/2020, a fim de que sejam adotadas as providências que entender, inclusive o protesto do título judicial e à inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sem prejuízo da cobrança judicial do débito.

Uma vez cumpridas todas as formalidades legais, remetam-se ao arquivo.

Recife- PE, data e assinatura eletrônicas.

MARCO AURÉLIO MENDONÇA DE ARAÚJO - Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO MENDONCA DE ARAUJO
03/01/2024 18:05:44
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 156932966

24010318054412300000153291802

IMPRIMIR GERAR PDF